

PANDUAN PENANGGAPAN OPERASI

Created by Arachi

BAB I

Pemeriksaan Dasar Pasien: Tanda-Tanda Vital dan Status Neurologis

1. Tanda Vital (*Vital Sign*)

Pemeriksaan *vital sign* atau TTV (tanda-tanda vital) adalah suatu prosedur mendasar bagi tim tenaga Kesehatan maupun layanan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya suatu kelainan, gangguan, perubahan fungsi organ tubuh dan masalah medis lainnya agar dapat membantu dokter menjadi suatu diagnosa. Berikut merupakan parameter vital sign.

Parameter	Tinggi	Normal	Rendah
Detak Jantung (HR)	> 100 BPM (Tachycardia)	60–100 BPM	< 60 BPM (Bradycardia)
Tekanan Darah	≥ 140 mmHg	90–120 mmHg	< 90 mmHg
Saturasi Oksigen (SpO ₂)	100% (optimal tinggi)	95–99%	< 90% (hipoksemia)
Laju Pernapasan (RR)	> 20 x/menit (Tachypnea)	12–20 x/menit	< 12 x/menit (Bradypnea)
EKG Irama	Atrial / Ventricular Tachyarrhythmia	Sinus rhythm (NSR)	Sinus Bradycardia

Catatan EKG: istilah seperti **Tachycardia** (cepat), **Bradycardia** (lambat), **Sinus rhythm** (normal), dan **arrhythmia** (irama tidak teratur) adalah interpretasi umum dari pola EKG.

2. Glasgow Coma Scale (GCS)

GCS dinilai dari 3 domain utama: **Eye Opening (E)**, **Verbal Response (V)**, dan **Motor Response (M)**. Nilainya dijumlahkan untuk skor total

A. Skor GCS

Skor Total	Kategori	Keterangan
13-15	Normal/Ringan	Kesadaran baik, respons kooperatif
9–12	Sedang	Kesadaran menurun, perlu pemantauan ketat
≤ 8	Berat / Kritis	Gangguan kesadaran signifikan, rawat ICU

B. Rincian Sub-Skor GCS

- Eye Opening (E)

E4	Spontan
E3	Terhadap suara
E2	Terhadap nyeri
E1	Tidak ada respons

- Verbal Response (V)

V5	Orientasi baik
V4	Bingung
V3	Kata tidak sesuai
V2	Suara tidak dapat dimengerti
V1	Tidak ada respons

- Motor Response (M)

M6	Mengikuti perintah
M5	Lokalisasi nyeri
M4	Fleksi normal (menarik dari nyeri)
M3	Fleksi abnormal (dekortikasi)
M2	Ekstensi abnormal (deserebrasi)
M1	Tidak ada respons

BAB II

Penanganan Operasi Luka Tusuk / Robek

1. Langkah-Langkah Operasi Luka Tusuk / Robek

Operasi luka tusuk atau luka robek dilakukan untuk menghentikan perdarahan, mencegah infeksi, dan memperbaiki kerusakan jaringan. Tindakan disesuaikan dengan kedalaman luka dan kondisi pasien. Berikut langkah-langkahnya :

PRA OPERASI	SAAT OPERASI	PASCA OPERASI
- Penilaian ABC (Airway, Breathing, Circulation) - Pemeriksaan tanda vital - Evaluasi kedalaman dan arah luka - Pemasangan infus dan monitoring	- Sterilisasi area luka - Insisi eksplorasi bila diperlukan - Kontrol perdarahan - Debridement jaringan non-viable - Irigasi dengan larutan steril - Penjahitan berlapis (otot, subkutan, kulit)	- Observasi perdarahan ulang - Pemberian antibiotik dan analgesik - Perawatan luka berkala

2. Contoh Kasus

Seorang pasien bernama **Namuh** mengalami luka tusuk pada lengan akibat tertancap besi dengan kedalaman ± 5 cm dan perdarahan aktif, lalu dibawa ke rumah sakit..

Pelaku	Dialog	/me	/do	/e
PRA OPERASI				
Dr	Dr : tolong cek tanda vital pasien.			
A1	A1 : tanda vital menurun, terdapat perdarahan aktif pada lengan.	memeriksa tanda vital pasien		mechanic

	Dr: segera bawa keruang operasi			
OPERASI				
Dokter (Dr)	-	mencuci tangan	tangan steril	cleanhands
Asisten 1 (A1)	Dr : siapkan set bedah minor dan set jahit. A1 : Baik dok	mengambil peralatan medis	terambil	box atau medbox *untuk mengambil barang bisa pakai /e mechanic atau mechanic4 (jika dibawah)
Asisten 2 (A2)	Dr : tolong pasangkan infus, oksigen, analgesik, kantong darah (jika kekurangan darah), dan nyalakan monitor ekg. A2 : Baik dok	memasang infus, oksigen, analgesik, kantong darah, ekg	terpasang	mechanic5, mechanic2, type
A2	Dr : Tolong suntikan anestesi lokak A2 : Sudah saya suntikan anestesi dan pasien sudah tidak merasakan nyeri.	menyuntikan anestesi	tersuntik, Pasien tidak merasakan nyeri.	syringe lalu parkingmeter *syringe untuk ambil suntik sedangkan parking meter untuk menyuntikan
Dr	Dr : Baik, Selamat pagi/siang/malam, saya dr.____ selaku dokter penanggung jawab operasi yang akan menangani tindakan hari ini. Kami sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, dan sudah berdasarkan hasil evaluasi, pasien didiagnosis luka tusuk lengan tanpa tembus organ, tindakan yang dilakukan adalah eksplorasi luka dan penjahitan berlapis. Dr : Sebelumnya pasien			Dr : /e Clipboard A1&A2 : Bartender *pakai mantra bartender jika sedang tidak melakukan apapun atau sedang menahan sesuatu.

	telah diberikan anestesi sesuai indikasi dan berada dalam kondisi anestesi adekuat. Infus terpasang dan mengalir dengan baik, oksigenasi adekuat, serta monitoring EKG aktif. Tanda vital pasien berada dalam kondisi stabil dengan tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 80 kali per menit dengan irama sinus normal, laju napas 18 kali per menit, suhu tubuh 36,8°C, dan saturasi oksigen 98%. Kondisi hemodinamik pasien dinilai stabil untuk menjalani prosedur operasi. Dr : Baik, langsung saja kita mulai operasi nya			
A1	Dr : bersihkan luka dengan nacl lalu oleskan iodine dan letakkan linen steril disekitar area luka. A1 : area operasi telah steril dok.	melakukan sterilisasi pada bagian yang akan di operasi	- progres 1/3 - progres 2/3 - progres 3/3 - selesai	clean
Dr	Dr : saya akan melakukan observasi luka tolong siap kan scalpel A1 : ini scalpel nya dok	membuka jaringan	Tampak jalur tusukan kedalam ± 5 cm tanpa tembus organ dengan pendarahan ringan	Dr : mechanic A1 : scalpel (lalu menunjuk kearah dokter untuk di berikan)
A2	Dr : suction!	melakukan suction	selesai	weld
A1	Dr : lakukan irigasi menggunakan NaCl	melakukan irigasi pada area luka	selesai	champagnespray
A2	Dr : tolong set jahit	mengambil Set Jahit	memberikan Set Jahit	medbox

Dr	Dr : baik, saya akan mulai penjahitan tolong dipotong benang nya saat saya katakan CUT. A1 : Baik dok	menjahit luka secara steril	Luka terjahit (1/5)*tergantung berapa jahitan yang kalian perlukan.	valet2
A1	Dr : Cut!	-	Cut *sampai jahitan 5/5	parkingmeter
A1&A2	Dr : untuk lukanya sudah terjahit dengan rapi tolong bersihkan sisa darah nya A1&A2 : baik dok	membersihkan sisa darah	progres 10% *sampai 100%	A1&A2 : clean Dr : Clipboard
A1	Dr : tolong pantau monitor ekg apakah sudah stabil? A1 : kondisi pasien telah stabil.	memantau monitor ekg	kondisi pasien stabil	type (jika liat dri komputer) / think (jika lihat dari layar)
A1	Dr : tolong sterilkan bekas jahitan.	mengoleskan povidone iodine pada area bekas jahitan	Area jahitan steril	clean
A2	Dr : balutkan area jahitan dengan kasa steril dan perban elastis, pastikan tekanan balutan pas.	membalut dengan kasa steril dan perban elastis	luka terbalut dengan rapi	mechanic
Dr	Dr : tolong suntikan analgesik			
A2		menyuntikan analgesik	berhasil disuntikan	syringe lalu Parkingmeter
Dr	Dr : tolong lepaskan masker oksigen, dan cabut elektroda ekg lalu matikan monitor ekg			
A1		melepas masker oksigen dan elektroda ekg, lalu matikan	selesai	mechanic

		monitor ekg.		
Dr	Dr : tolong Asisten 1 bawa pasien ke ruang rawat inap dan Asisten 2 tolong bersihkan ruang operasi			
PASCA OPERASI				
Dr	Dr : tolong suntikan penetral anestesi			clipboard
A2		menyuntikan penetral bius	tersuntikan	syringe lalu Parkingmeter
Dr	Dr : Tolong bangunkan pasien			
A1		membangun kan pasien	pasien terbangun	mechanic
Dr	"Menjelaskan kepada pasien dan keluarga operasi apa yang telah dilakukan, kondisi luka, dan perawatan lanjutan."			

BAB III

Penanganan Operasi Rekontruksi Tulang

1. Langkah-Langkah Operasi Rekontruksi Tulang

Operasi rekonstruksi tulang dilakukan untuk mengembalikan posisi anatomis tulang, menjaga stabilitas, dan memungkinkan proses penyembuhan optimal pada kasus patah tulang. Berikut langkah-langkah nya :

PRA OPERASI	SAAT OPERASI	PASCA OPERASI
- Pemeriksaan radiologi (rontgen/CT) - Imobilisasi sementara - Penilaian kondisi umum pasien	- Insisi kulit dan jaringan subkutan - Ekspos tulang menggunakan retraktor - Reposisi fragmen tulang - Pemasangan plate/pen - Pengecekan stabilitas - Irigasi dan penutupan luka berlapis	- Imobilisasi - Kontrol nyeri - Fisioterapi bertahap - Evaluasi radiologi lanjutan

2. Contoh Kasus

Seorang pasien bernama **Mimo** sedang balapan dengan **Amil** saat **Mimo** memimpin balapan tersebut **Ayden** yang sedang naik mobil dengan ngebut tidak melihat **Mimo** dan akhir nya **Mimo** terjatuh dengan lengan kanan yang sudah bengkok.

Pelaku	Dialog	/me	/do	/e
PRA OPERASI				
Dr	Dr : cek kondisi pasien			
A1	A1 : kondisi pasien stabil Dr : segera bawa ke ruang radiologi untuk di periksa lebih lanjut.	memeriksa tanda vital pasien		mechanic
RUANG RADIOLOGI				
Dr	Dr : buka baju pasien			

A2		membuka baju pasien dan menyimpan dengan rapi	baju tersimpan	mechanic lalu box
A2	Dr : nyalakan mesin X-ray	menyalakan mesin X-ray	mesin hidup	atm
Dr	Dr : ok saya akan melakukan X-Ray scanning	melakukan scan	Progres 10%	type
Dr	Dr : baik, dari hasil scanning Terdapat deformitas pada lengan kanan akibat fraktur. Jadi kita akan melakukan operasi rekonstruksi lengan kanan Dr : tolong segera bawa pasien keruang operasi			clipboard
OPERASI				
Dokter (Dr)	-	mencuci tangan	tangan steril	cleanhands
Asisten 1 (A1)	Dr : siapkan set ORIF plate dan screw. A1 : Baik dok	mengambil peralatan medis	terambil	box atau medbox *untuk mengambil barang bisa pakai /e mechanic atau mechanic4 (jika dibawah)
Asisten 2 (A2)	Dr : tolong pasang infus, oksigen, analgesik, kantong darah (jika kekurangan darah), dan nyalakan monitor ekg. A2 : Baik dok	memasang infus, oksigen, analgesik, kantong darah, ekg	terpasang	mechanic5, mechanic2, type
A2	Dr : Tolong suntikan anestesi umum" (propofol/kentamin) A2 : Sudah saya suntikan anestesi dan pasien sudah tidak responsif.	menyuntikan anestesi	tersuntik, Pasien tertidur dan tidak responsif.	syringe lalu parkingmeter *syringe untuk ambil suntik sedangkan parking meter untuk menyuntikan

Dr	Dr : Baik, Selamat pagi/siang/malam, saya dr._____ selaku dokter penanggung jawab operasi yang akan menangani tindakan hari ini. Kami sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, dan sudah berdasarkan hasil evaluasi, pasien didiagnosis fraktur lengan kanan, akan dilakukan operasi ORIF untuk reposisi dan fiksasi tulang.. Dr : Pasien telah berada dalam anestesi umum dengan jalan napas terkontrol. Infus dan oksigen mengalir dengan baik, serta pemantauan EKG menunjukkan irama sinus normal tanpa gangguan konduksi. Tanda vital pasien stabil dengan tekanan darah 125/80 mmHg, denyut nadi 76 kali per menit, laju napas 16 kali per menit, suhu tubuh 36,6°C, dan saturasi oksigen 99%. Pasien dinyatakan stabil dan siap menjalani tindakan rekonstruksi tulang. Dr : Baik, langsung saja kita mulai operasi nya			Dr : /e Clipboard A1&A2 : Bartender *pakai mantra bartender jika sedang tidak melakukan apapun atau sedang menahan sesuatu.
A1	Dr : bersihkan luka dengan nacl lalu oleskan iodine dan letakkan linen steril disekitar area luka. A1 : area operasi telah steril dok.	melakukan sterilisasi pada bagian yang akan di operasi	- progres 1/3 - progres 2/3 - progres 3/3 - selesai	clean
Dr	Dr : tolong siap kan scalpel A1 : ini scalpel nya dok	membuat sayatan kulit dan jaringan	selesai	Dr : mechanic A1 : scalpel (lalu menunjuk kearah

		subkutan secara hati-hati		dokter untuk di berikan)
A2	Dr : suction!	melakukan suction	selesai	weld
A1	Dr : ambilkan retraktor lalu pasangkan	mengambil rektaktor	memasangkannya retraktor	mechanic lalu tahan dengan bartender
A2	Dr : kontrol pendarahan lakukan suction	melakukan suction	selesai	weld
Dr	Dr: saya akan lakukan reposisi fragmen tulang hingga alignment anatomis.	menyelaraskan fragmen fraktur	Fragmen tulang kembali sejajar	mechanic
A2	Dr : ambilkan plate dan screw	mengambil plate	plate terambil	mechanic/mechanic 4
Dr		memasang plate	1/4 plate terpasang dengan rapi	drilltool
A1	Dr : lepaskan retraktor dan lakukan irigasi menggunakan NaCl	melakukan irigasi pada area luka	selesai	champagnespray
A2	Dr : tolong set jahit	mengambil Set Jahit	memberikan Set Jahit	medbox
Dr	Dr : baik, saya akan mulai penjahitan tolong dipotong benang nya saat saya katakan CUT. A1 : Baik dok	menjahit luka secara steril	Luka terjahit (1/5)*tergantung berapa jahitan yang kalian perlukan.	valet2
A1	Dr : Cut!	-	Cut *sampai jahitan 5/5	parkingmeter
A1&A2	Dr : untuk lukanya sudah terjahit dengan rapi tolong bersihkan sisa darah nya A1&A2 : baik dok	membersihkan sisa darah	progres 10% *sampai 100%	A1&A2 : clean Dr : Clipboard
A1	Dr : tolong pantau monitor ekg apakah sudah stabil? A1 : kondisi pasien telah	memantau monitor ekg	kondisi pasien stabil	type (jika liat dri komputer) / think (jika lihat dari layar)

	stabil.			
A1	Dr : tolong sterilkan bekas jahitan.	mengoleskan povidone iodine pada area bekas jahitan	Area jahitan steril	clean
A2	Dr : balutkan area jahitan dengan kasa steril dan perban elastis, pastikan tekanan balutan pas.	membalut dengan kasa steril dan perban elastis	luka terbalut dengan rapi	mechanic
Dr	Dr : tolong lepaskan masker oksigen, dan cabut elektroda ekg lalu matikan monitor ekg			
A1		melepas masker oksigen dan elektroda ekg, lalu matikan monitor ekg.	selesai	mechanic
Dr	Dr : tolong Asisten 1 bawa pasien ke ruang rawat inap dan Asisten 2 tolong bersihkan ruang operasi			
PASCA OPERASI				
Dr	Dr : tolong suntikan penetral anestesi			clipboard
A2		menyuntikan penetral bius	tersuntikan	syringe lalu Parkingmeter
Dr	Dr : Tolong bangunkan pasien			
A1		membangun kan pasien	pasien terbangun	mechanic
Dr	“Menjelaskan kepada pasien dan keluarga operasi apa yang telah dilakukan, kondisi luka, dan perawatan lanjutan.”			

BAB IV

Penanganan Operasi Luka Bakar

1. Langkah-Langkah Operasi Luka Bakar

Operasi luka bakar meliputi debridement jaringan mati, tindakan pelepas tekanan bila perlu (escharotomy), pembersihan dan kontrol infeksi, penutupan luka dengan skin graft (bila diperlukan), serta rekonstruksi lanjutan untuk memulihkan fungsi dan bentuk tubuh. Berikut langkah-langkah nya :

PRA OPERASI	SAAT OPERASI	PASCA OPERASI
- Penilaian luas dan derajat luka bakar - Resusitasi cairan - Monitoring intensif	- Debridement jaringan mati - Irigasi berulang - Aplikasi salep luka bakar - Penutupan luka (skin graft bila indikasi)	- Perawatan intensif di burn unit - Antibiotik dan nutrisi adekuat - Ganti balutan rutin

2. Contoh Kasus

Seorang pasien bernama **Zan** sedang mengebut di jalan raya namun saat ingin berbelok setir mobilnya terlepas dan menabrak pom bensin terdekat lalu terjadi ledakan dan lengan kiri **Zan** terbakar sampai melepuh lalu langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan.

Pelaku	Dialog	/me	/do	/e
PRA OPERASI				
Dr	Dr : luka bakar luas dengan jaringan nekrotik.	memeriksa tanda vital pasien		mechanic
OPERASI				
Dokter (Dr)	-	mencuci tangan	tangan steril	cleanhands
Asisten 1 (A1)	Dr : tolong siapkan alat-alat untuk operasi. A1 : Baik dok	mengambil peralatan medis	terambil	box atau medbox *untuk mengambil barang bisa pakai /e

				mechanic atau mechanic4 (jika dibawah)
Asisten 2 (A2)	Dr : tolong pasangkan infus, oksigen, analgesik, kantong darah (jika kekurangan darah), dan nyalakan monitor ekg. A2 : Baik dok	memasang infus, oksigen, analgesik, kantong darah, ekg	terpasang	mechanic5, mechanic2, type
A2	Dr : Tolong suntikan anestesi umum" (propofol/kentamin) A2 : Sudah saya suntikan anestesi dan pasien sudah tidak responsif.	menyuntikan anestesi	tersuntik, Pasien tertidur dan tidak responsif.	syringe lalu parkingmeter *syringe untuk ambil suntik sedangkan parking meter untuk menyuntikan
Dr	Dr : Baik, Selamat pagi/siang/malam, saya dr.____ selaku dokter penanggung jawab operasi yang akan menangani tindakan hari ini. Kami sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, dan sudah berdasarkan hasil evaluasi, pasien dengan luka bakar derajat II–III, akan dilakukan debridement jaringan nekrotik. Dr : Pasien telah mendapatkan anestesi umum dan stabilisasi cairan sebelumnya. Monitoring EKG menunjukkan irama sinus reguler , tanpa tanda aritmia. Tanda vital saat ini menunjukkan tekanan darah 118/78 mmHg , denyut nadi 88 kali per menit , laju napas 20 kali per menit , suhu tubuh 37,0°C , dan saturasi oksigen 97% dengan			Dr : /e Clipboard A1&A2 : Bartender *pakai mantra bartender jika sedang tidak melakukan apapun atau sedang menahan sesuatu.

	oksigen tambahan. Kondisi pasien cukup stabil untuk dilakukan tindakan debridement luka bakar. Dr : Baik, langsung saja kita mulai operasi nya			
Dr	Dr : sediakan cawan steril saya akan memotong dan mengangkat jaringan mati	mengambil jaringan mati	jaringan mati terangkat	Dr : parkingmeter A1 : foodtray
A2	Dr : lakukan suction	melakukan suction	selesai	weld
A1	Dr : lakukan irigasi menggunakan NaCl untuk mengangkat sel mati	melakukan irigasi pada area luka	selesai	champagnespray
A2	Dr : tolong oleskan silver sulfadiazine	mengoleskan salep	teroles	clean
A1	Dr : balut berlapis di area luka bakar	membalut lengan pasien	1/5	mechanic
A1	Dr : tolong pantau monitor ekg apakah sudah stabil? A1 : kondisi pasien telah stabil.	memantau monitor ekg	kondisi pasien stabil	type (jika liat dri komputer) / think (jika lihat dari layar)
Dr	Dr : tolong lepaskan masker oksigen, dan cabut elektroda ekg lalu matikan monitor ekg			
A1		melepas masker oksigen dan elektroda ekg, lalu matikan monitor ekg.	selesai	mechanic
Dr	Dr : tolong Asisten 1 bawa pasien ke ruang rawat inap dan Asisten 2 tolong bersihkan ruang operasi			
PASCA OPERASI				

Dr	Dr : tolong suntikan penetral anestesi			clipboard
A2		menyuntikan penetral bius	tersuntikan	syringe lalu Parkingmeter
Dr	Dr : Tolong bangunkan pasien			
A1		membangun kan pasien	pasien terbangun	mechanic
Dr	"Menjelaskan kepada pasien dan keluarga operasi apa yang telah dilakukan, kondisi luka, dan perawatan lanjutan."			

BAB V

Penanganan Operasi Luka Tembak

1. Langkah-Langkah Operasi Luka Tembak

Operasi luka tembak meliputi stabilisasi pasien, eksplorasi jalur proyektil, kontrol perdarahan, debridement jaringan rusak, perbaikan organ yang terkena, irigasi luka, serta penutupan atau pemasangan drain sesuai kondisi. Berikut langkah-langkah nya :

PRA OPERASI	SAAT OPERASI	PASCA OPERASI
- Pasien datang dengan luka tembak. - Cek jumlah luka (inlet / outlet). - Hentikan perdarahan. - Infus + EKG. - Rontgen untuk lihat peluru.	- Anestesi umum. - Luka diperlebar secukupnya. - Jalur peluru ditelusuri. - Peluru/fragmen diambil bila aman. - Jaringan rusak dibersihkan. - Perdarahan dikendalikan. - Irigasi NaCl. - Jahit luka / pasang drain.	- Antibiotik + anti tetanus. - Observasi perdarahan. - Cek fungsi saraf/otot sekitar.

2. Contoh Kasus

Seorang pasien bernama **Kuro** sedang foto seseorang namun secara kebetulan ada peluru nyasar dari lapangan tembak polisi dan tertembak tepat di dada kiri dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

Pelaku	Dialog	/me	/do	/e
PRA OPERASI				
Dr	Dr : tolong cek tanda vital pasien.			
A1	A1 : tanda vital menurun	memeriksa		mechanic

	dan terjadi pendarahan ringan.(atau bisa dijawab pakai data ekg) Dr: segera bawa keruang radiologi untuk dilakukan Rontgen	tanda vital pasien		
RUANG RADIOLOGI				
Dr	Dr : buka baju pasien			
A2		membuka baju pasien dan menyimpan dengan rapi	baju tersimpan	mechanic lalu box
A2	Dr : nyalakan mesin X-ray	menyalakan mesin X-ray	mesin hidup	atm
Dr	Dr : ok saya akan melakukan X-ray scanning	melakukan scan	Progres 10%	type
Dr	Dr : baik, dari hasil scanning Terdapat peluru pada dada kiri yang menunjukkan proyektil peluru di hemitoraks kiri dengan tanda perdarahan paru, tanpa kolaps paru total Dr : tolong segera bawa pasien keruang operasi			clipboard
OPERASI				
Dokter (Dr)	-	mencuci tangan	tangan steril	cleanhands
Asisten 1 (A1)	Dr : tolong siapkan alat-alat untuk operasi. A1 : Baik dok	mengambil peralatan medis	terambil	box atau medbox *untuk mengambil barang bisa pakai /e mechanic atau mechanic4 (jika dibawah)
Asisten 2 (A2)	Dr : tolong pasangkan infus, oksigen, analgesik,	memasang infus,	terpasang	mechanic5, mechanic2, type

	kantong darah (jika kekurangan darah), dan nyalakan monitor ekg. A2 : Baik dok	oksigen, analgesik, kantong darah, ekg		
A2	Dr : Tolong suntikan anestesi umum" (propofol/kentamin) A2 : Sudah saya suntikan anestesi dan pasien sudah tidak responsif.	menyuntikan anestesi	tersuntik, Pasien tertidur dan tidak responsif.	syringe lalu parkingmeter *syringe untuk ambil suntik sedangkan parking meter untuk menyuntikan
Dr	Dr : Baik, Selamat pagi/siang/malam, saya dr.____ selaku dokter penanggung jawab operasi yang akan menangani tindakan hari ini. Kami sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, dan sudah berdasarkan hasil evaluasi, pasien dengan luka tembak dada kiri, dilakukan eksplorasi luka dan kontrol perdarahan. Dr : Pasien telah terpasang infus besar, oksigen, serta monitor EKG sebelum operasi. Pemantauan EKG menunjukkan irama sinus dengan frekuensi terkontrol. Tanda vital pasien menunjukkan tekanan darah 115/75 mmHg, denyut nadi 90 kali per menit, laju napas 20 kali per menit, suhu tubuh 36,9°C, dan saturasi oksigen 96%. Setelah stabilisasi awal, kondisi pasien dinilai cukup stabil untuk dilakukan eksplorasi bedah luka tembak. Dr : Baik, langsung saja kita mulai operasi nya			Dr : /e Clipboard A1&A2 : Bartender *pakai mantra bartender jika sedang tidak melakukan apapun atau sedang menahan sesuatu.

A1	Dr : bersihkan luka dengan nacl lalu oleskan iodine dan letakkan linen steril disekitar area luka. A1 : area operasi telah steril dok.	melakukan sterilisasi pada bagian yang akan di operasi	- progres 1/3 - progres 2/3 - progres 3/3 - selesai	clean
Dr	Dr : saya akan melakukan observasi luka tolong siap kan scalpel A1 : ini scalpel nya dok	membuat sayatan pada dinding dada	tampak jalur peluru sepanjang ±8 cm menuju jaringan paru	Dr : mechanic A1 : scalpel (lalu menunjuk kearah dokter untuk di berikan)
A1	Dr : pasang retraktor dan rib spreader	memasang retraktor dan rib spreader	terpasang	mechanic
A2	Dr : suction! kontrol pendarahan	melakukan suction	selesai	weld
Dr	Dr : siapkan cawan	mengamank an peluru	peluru terambil	Dr : valet2 A1 : foodtray
Dr	Dr : saya akan melakukan eksplorasi paru dan organ vital	memeriksa paru dan jaringan sekitar	Tidak ditemukan perforasi mayor	mechanic
A2	Dr : lakukan irigasi lalu pasang chest tube	melakukan irigasi dan memasang chest tube	chest tube terpasang dan berfungsi	champagnespray lalu mechanic
Dr	Dr : baik, saya akan mulai penjahitan tolong dipotong benang nya saat saya katakan CUT. A1 : Baik dok	menjahit luka secara steril	Luka terjahit (1/5)*tergantun g berapa jahitan yang kalian perlukan.	valet2
A1	Dr : Cut!	-	Cut *sampai jahitan 5/5	parkingmeter
A1&A2	Dr : untuk lukanya sudah terjahit dengan rapi tolong bersihkan sisa darah nya A1&A2 : baik dok	membersihk an sisa darah	progres 10% *sampai 100%	A1&A2 : clean Dr : Clipboard
A1	Dr : tolong pantau monitor ekg apakah sudah stabil?	memantau monitor ekg	kondisi pasien stabil	type (jika liat dri komputer) / think

	A1 : kondisi pasien telah stabil.			(jika lihat dari layar)
A1	Dr : tolong sterilkan bekas jahitan.	mengoleskan povidone iodine pada area bekas jahitan	Area jahitan steril	clean
A2	Dr : balutkan area jahitan dengan kasa steril dan perban elastis, pastikan tekanan balutan pas.	membalut dengan kasa steril dan perban elastis	luka terbalut dengan rapi	mechanic
Dr	Dr : tolong suntikan analgesik			
A2		menyuntikan analgesik	berhasil disuntikan	syringe lalu Parkingmeter
Dr	Dr : tolong lepaskan masker oksigen, dan cabut elektroda ekg lalu matikan monitor ekg			
A1		melepas masker oksigen dan elektroda ekg, lalu matikan monitor ekg.	selesai	mechanic
Dr	Dr : tolong Asisten 1 bawa pasien ke ruang rawat inap dan Asisten 2 tolong bersihkan ruang operasi			
PASCA OPERASI				
Dr	Dr : tolong suntikan penetral anestesi			clipboard
A2		menyuntikan penetral bius	tersuntikan	syringe lalu Parkingmeter
Dr	Dr : Tolong bangunkan pasien			

A1		membangun kan pasien	pasien terbangun	mechanic
Dr	“Menjelaskan kepada pasien dan keluarga operasi apa yang telah dilakukan, kondisi luka, dan perawatan lanjutan.”			

BAB VI

Penanganan Operasi Kraniotomi

1. Langkah-Langkah Operasi Kraniotomi

observasi ketat tanda neurologis, imobilisasi servikal, kontrol nyeri & mual, serta operasi bedah saraf hanya bila ditemukan perdarahan atau peningkatan tekanan intrakranial. Berikut langkah-langkah nya :

PRA OPERASI	SAAT OPERASI	PASCA OPERASI
- Nilai GCS. - CT Scan kepala. - Stabilisasi hemodinamik	- Insisi kulit kepala Kraniotomi dan pengangkatan bone flap - Pembukaan dura mater - Evakuasi hematoma - Kontrol perdarahan - Penutupan dura dan reposisi tulang - Penjahitan kulit kepala	- Perawatan ICU - Monitoring GCS dan tanda vital - Pencegahan kejang dan edema otak

2. Contoh Kasus

Seorang pasien bernama **Alan** dipukul keras dengan barbel saat berada di gym oleh **Vale**, dan terjadi pendarahan pada kepala lalu di larikan kerumah sakit.

Pelaku	Dialog	/me	/do	/e
PRA OPERASI				
Dr	Dr : tolong cek tanda vital pasien.			
A1	A1 : tanda vital menurun dan terjadi pendarahan ringan.(atau bisa dijawab pakai data ekg) Dr: segera bawa keruang radiologi untuk di lakukan CT-scan	memeriksa tanda vital pasien		mechanic
RUANG RADIOLOGI				

Dr	Dr : buka baju pasien			
A2		membuka baju pasien dan menyimpan dengan rapi	baju tersimpan	mechanic lalu box
A2	Dr : nyalakan mesin CT scan	menyalakan mesin CT scan	mesin hidup	atm
Dr	Dr : ok saya akan melakukan CT scan	melakukan scanning	Progres 10%	type
Dr	Dr : baik, dari hasil scanning menunjukkan hematoma intrakranial dengan peningkatan tekanan intrakranial Dr : tolong segera bawa pasien keruang operasi			clipboard
OPERASI				
Dokter (Dr)	-	mencuci tangan	tangan steril	cleanhands
Asisten 1 (A1)	Dr : tolong siapkan alat-alat untuk operasi. A1 : Baik dok	mengambil peralatan medis	terambil	box atau medbox *untuk mengambil barang bisa pakai /e mechanic atau mechanic4 (jika dibawah)
Asisten 2 (A2)	Dr : tolong pasang infus, oksigen, analgesik, kantong darah (jika kekurangan darah), dan nyalakan monitor ekg. A2 : Baik dok	memasang infus, oksigen, analgesik, kantong darah, ekg	terpasang	mechanic5, mechanic2, type
A2	Dr : Tolong suntikan anestesi umum" (propofol/kentamin) A2 : Sudah saya suntikan anestesi dan pasien sudah tidak responsif.	menyuntikan anestesi	tersuntik, Pasien tertidur dan tidak responsif.	syringe lalu parkingmeter *syringe untuk ambil suntik sedangkan parking meter untuk menyuntikan

Dr	Dr : Baik, Selamat pagi/siang/malam, saya dr._____ selaku dokter penanggung jawab operasi yang akan menangani tindakan hari ini. Kami sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, dan sudah berdasarkan hasil evaluasi, pasien didiagnosis hematoma intrakranial dengan peningkatan tekanan intrakranial, sehingga diputuskan dilakukan operasi kraniotomi untuk evakuasi hematoma. Dr : Pasien telah berada dalam anestesi umum dengan ventilasi terkontrol. Infus dan oksigen berjalan optimal, serta monitoring EKG menunjukkan irama sinus normal tanpa aritmia. Tanda vital pasien stabil dengan tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 78 kali per menit, laju napas 16 kali per menit, suhu tubuh 36,7°C, dan saturasi oksigen 98%. Secara hemodinamik pasien berada dalam kondisi stabil untuk menjalani prosedur kraniotomi. Dr : Baik, langsung saja kita mulai operasi nya			Dr : /e Clipboard A1&A2 : Bartender *pakai mantra bartender jika sedang tidak melakukan apapun atau sedang menahan sesuatu.
A1	Dr : cukur rambut dan bersihkan luka dengan nacl lalu oleskan iodine dan letakkan linen steril disekitar area luka. A1 : area operasi telah steril dok.	mencukur rambut dan melakukan sterilisasi pada bagian yang akan di operasi	- progres 1/3 - progres 2/3 - progres 3/3 - selesai	clean

Dr	Dr : tolong siap kan scalpel A1 : ini scalpel nya dok	membuat sayatan kulit dan jaringan subkutan	selesai	Dr : mechanic A1 : scalpel (lalu menunjuk kearah dokter untuk di berikan)
Dr		membuat burr hole dan mengangkat bone flap	Tulang tengkorak terbuka	drilltool lalu mechanic
Dr		membuka dura mater secara hati-hati	Otak terekspos	mechanic
A2	Dr : suction! kontrol pendarahan	melakukan suction	selesai	weld
Dr	Dr : saya akan mengangkat bekuan darah (hematoma)	mengangkat bekuan darah	Tekanan intrakranial berkurang	Dr : parkingmeter A1 : foodtray
Dr		menutup dura dan mengembalikan tulang tengkorak	Bone flap terfiksasi	mechanic
A2	Dr : lakukan irigasi	melakukan irigasi	selesai	champagnespray
Dr	Dr : baik, saya akan mulai penjahitan tolong dipotong benang nya saat saya katakan CUT. A1 : Baik dok	menjahit luka secara steril	Luka terjahit (1/5)*tergantung berapa jahitan yang kalian perlukan.	valet2
A1	Dr : Cut!	-	Cut *sampai jahitan 5/5	parkingmeter
A1&A2	Dr : untuk lukanya sudah terjahit dengan rapi tolong bersihkan sisa darah nya A1&A2 : baik dok	membersihkan sisa darah	progres 10% *sampai 100%	A1&A2 : clean Dr : Clipboard
A1	Dr : tolong pantau monitor ekg apakah sudah stabil? A1 : kondisi pasien telah stabil.	memantau monitor ekg	kondisi pasien stabil	type (jika liat dri komputer) / think (jika lihat dari layar)

A1	Dr : tolong sterilkan bekas jahitan.	mengoleskan povidone iodine pada area bekas jahitan	Area jahitan steril	clean
A2	Dr : balutkan area jahitan dengan kasa steril dan perban elastis, pastikan tekanan balutan pas.	membalut dengan kasa steril dan perban elastis	luka terbalut dengan rapi	mechanic
Dr	Dr : tolong suntikan analgesik			
A2		menyuntikan analgesik	berhasil disuntikan	syringe lalu Parkingmeter
Dr	Dr : tolong lepaskan masker oksigen, dan cabut elektroda ekg lalu matikan monitor ekg			
A1		melepas masker oksigen dan elektroda ekg, lalu matikan monitor ekg.	selesai	mechanic
Dr	Dr : tolong Asisten 1 bawa pasien ke ruang rawat inap dan Asisten 2 tolong bersihkan ruang operasi			
PASCA OPERASI				
Dr	Dr : tolong suntikan penetral anestesi			clipboard
A2		menyuntikan penetral bius	tersuntikan	syringe lalu Parkingmeter
Dr	Dr : Tolong bangunkan pasien			
A1		membangun kan pasien	pasien terbangun	mechanic

Dr	“Menjelaskan kepada pasien dan keluarga operasi apa yang telah dilakukan, kondisi luka, dan perawatan lanjutan.”			
----	--	--	--	--